

약제급여평가위원회 평가 결과

Indium(111In) chloride sol. 1mCi(37MBq),
Pentetate 0.1mg

(이메덱스인듐펜테틱산주, 약진이메덱스(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1ml/병 중 Indium(111In) chloride sol. 1mCi(37MBq), Pentetate 0.1mg

☐ **효능 효과 :**

이 약은 진단용으로만 사용한다.

- 뇌수조 신티그래피 :

뇌척수 폐색 감지

정상압 수두증(물뇌증)과 그 외의 수두증(물뇌증)의 구별

- 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2011년 제14차 약제급여평가위원회: 2011년 11월 17일

2012년 제4차 약제급여평가위원회: 2012년 3월 22일 [재평가]

- 중앙심사평가조정위원회: 2011년 11월 14일, 2012년 3월 12일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2011년 14차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “뇌수조 신티그래피 (뇌척수 폐색감지, 정상압 수두증(물뇌증)과 그 외의 수두증(물뇌증)의 구별), 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)의 진단”에 허가받은 약제로 유일하게 뇌조조영술에 사용하는 약제로 허가 받았으나 CT 또는 MRI 검사가 금기인 환자에 적용 시 임상적 유용성 개선 및 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

□ 최종결과

○ 2012년 제4차 약제급여평가위원회평가결과: 기심의결과유지(비급여)

- 신청품은 “뇌수조 신티그래피 (뇌척수 폐색감지, 정상압 수두증과 그 외의 수두증의 구별), 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)”에 허가받은 약제로 ‘정상압 수두증과 그 외의 수두증의 구별에 CT 또는 MRI 검사가 금기이거나 CT 또는 MRI로 진단이 불가능한 경우’에 임상적 유용성이 인정되나, 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “1.뇌수조 신티그래피: 뇌척수 폐색감지, 정상압수두증(물뇌증)과 그 외의 수두증(물뇌증)의 구별, 2. 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)의 진단”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않는 점 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 행위 급여 목록에 등재되어 있는 방사성 동위원소 뇌조조영술에 사용하도록 허가 받은 유일한 약제임.
- 중추신경계 장애를 진단하기 위해 CT, MRI가 많이 사용되지만 이와 같은 방법으로 진단이 되지 않는 경우 방사선적 진단을 실시하도록 권장되고 있고¹⁾, 뇌조조영술(cisternography)은 뇌척수액의 동역학(kinetics)을 관찰하고 수두증의 유형을 평가하는데 있어 보조적인 역할을 하는 진단적 특이성이 있음²⁾.
- 정상압수두증은 치매의 원인 질환 중 하나로 뇌척수액 단락(shunt)으로 치료 가능한 질환이며 40~60%의 환자에서 수술 후 호전을 보인다는 점에서 정상압수두증에 의한 치매

와 퇴행성 치매의 감별은 매우 중요하며 방사성동위원소 뇌조조영술이 진단에 유용함³⁾.

- 학회에서는 인덱스를 이용한 방사성 동위원소 뇌조조영술은 VP(ventriculoperitoneal) shunt 등으로 증상이 호전될 수 있는 정상압수두증과 그 외의 수두증의 구별에는 CT 나 MRI로는 확진에 있어 대체가 불가능한 검사법이라는 의견임⁴⁾.
- 중앙심사평가조정위원회에서는 ‘정상압 수두증과 그 외의 수두증의 구별’에 ① CT 또는 MRI 검사에 급기인 경우, ② CT 또는 MRI 검사도 진단이 불가능한 경우 진료의사의 사유서 첨부시 급여를 인정하는 것이 타당하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 급여목록에 동일한 적응증에 허가받은 약제는 없으며, 현재 방사성동위원소 뇌조조영술에 사용하는 ^{99m}Tc-DTPA⁵⁾는 신장신틸그라피에 의한 신장 질환 진단에 허가된 약제이므로 대체 가능한 약제는 없음.
- 신청품의 1회 소요비용은 ■■■■■원임⁶⁾.
- 제약사에서 제출한 경제성평가 자료는 대상환자군 및 검사자 중 수두증 확진비율, 비용 등의 근거자료가 불분명하며, 「의약품 경제성평가지침」 및 자료작성요령에 근거하여 작성되지 않았으므로 경제성평가 자료로 볼 수 없음.

○ 재정 영향⁷⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수⁸⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁰⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 됨.
- 다만, 제약사 제출 예상 사용량은 연간 ■■■건 기준이므로 대상환자수(건수)가 감소 시 절대재정소요금액도 감소할 것으로 보임.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 등재되어 있지 않음.
 - 다만, 함량이 상이한 품목은 미국, 일본에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Imaging of skull base cerebrospinal fluid leaks in adults, 2008, Radiology
- 2) Nuclear Medicine 2nd ed(2006)
- 3) 고창순 핵의학 제3판(2008), 고려의학

- 4) 대한핵의학회()
- 5) 싱코르 디티피에이테크네튬 주[®]
- 6) 신청품 1회 투약비용(원) + 관련행위 단위비용(원; 방사성 동위원소 뇌조조영술(HC020 행위수가 1,250.59) x 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 의료기관 중 병원, 요양병원 및 종합병원 접수당 단가(66.0원))
- 7) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 8) 2011년 EDI 청구환자수 [상병으로 뇌조조영술(HC020) 행위를 청구한 환자수]
- 9) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)
- 10) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청품 소요비용